Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

HEMOGRAMA, sangue total

RESULTADO			VALORES DE REFERÊNCIA Masc: Maior ou igual a 18 anos
ERITRÓCITOS	: 5,04	milhões/mm3	4,32 a 5,67
HEMOGLOBINA	: **15,1**	**g/dL**	**13,3 a 16,5**
HEMATÓCRITO	: 45,3	%	39,2 a 49,0
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA	: 30,0	pg	27,7 a 32,7
VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO	: 89,9	fL	81,7 a 95,3
CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA	: 33,3	g/dL	32,4 a 36,0
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DO VOLUME ERITROCITÁRIO (RDW)	: 13,6	%	11,8 a 14,1

CARACTERES MORFOLÓGICOS:
normais

SÉRIE BRANCA

RESULTADO		%	/mm3	VALORES DE REFERÊNCIA Masc: Maior ou igual a 18 anos /mm3
LEUCÓCITOS			8.190	3.650 a 8.120
Neutrófilos	:	47,0	3.850	1.590 a 4.770
Eosinófilos	:	7,7	630	34 a 420
Basófilos	:	0,6	50	10 a 80
Linfócitos	:	39,2	3.210	1.120 a 2.950
Monócitos	:	5,5	450	260 a 730

CARACTERES MORFOLÓGICOS:
não foram observados caracteres tóxico-degenerativos nos neutrófilos; não foram observadas atipias linfocitárias

PLAQUETAS

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA Masc: Maior ou igual a 18 anos
TOTAL DE PLAQUETAS: 352.000/mm3	151.000 a 304.000/mm3
VOLUME PLAQUETÁRIO MÉDIO: 9,1 fL	9,2 a 12,6 fL

NOTA(1): Os valores de referência para adultos são baseados em um estudo com 95 mil amostras de brasileiros saudáveis.

NOTA(2): Exame automatizado por citometria de fluxo fluorescente e impedância, com confirmação das contagens e análise morfológica realizadas por microscopia, quando aplicável.

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 03/02/2026 14:49 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA MARIA DE LOURDES L FERRARI CHAUFFAILLE CRM 44281SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: FFA029776048BE0B851B28A62377900B9AEA47CC048F0D2316CB0F6DE7A5B92A

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA, soro
Método: Colorimétrico

RESULTADO		VALORES DE REFERÊNCIA
		Acima de 12 anos:
Ferro	: 155 mcg/dL	65 a 175 mcg/dL
Ligação do ferro, capacidade total	: 305 mcg/dL	250 a 425 mcg/dL
Saturação da Transferrina	: 51 %	20 a 50 %

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 09:05 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 44F7E1A81C30377C87D42DC1C8BCF28D4156533C2D297BD521F5D393FBA1B709

FERRO, soro
Método: Colorimétrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
155 mcg/dL	Acima de 12 anos: 65-175 mcg/dL

NOTA: Os níveis de ferro sérico possuem significativa variação circadiana. O diagnóstico laboratorial de deficiência ou sobrecarga de ferro deve ser realizado utilizando-se demais parâmetros associados ao metabolismo do ferro.

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 09:05 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 17D22B817C4D1683FD6BB758C8D2B8DFEE66F6CD6A4AE6B5C22681C623CEF2FF

TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)
ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), Atividade no soro
Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
36 U/L	maior que 1 ano: até 41 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 09:06 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 8CE5B602176CB73E351C28EB4D065583F32B5015486905C4797C0C3A27224E22

TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)
ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), Atividade no soro
Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
25 U/L	maior que 2 anos: até 40 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 09:06 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 09541E30091DB778215C8CE4616758B41296CE39D20872A365F10BFA1FB6FD4B

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

CREATININA, soro
Método: Cinético colorimétrico

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
1,20 mg/dL	Acima de 12 anos: 0,70 a 1,30

ESTIMATIVA DA FILTRAÇÃO GLOMERULAR ==========
Método: Cálculo da estimativa da taxa de filtração glomerular baseado nas equações CKD-EPI 2009, CKD-EPI 2021 e MDRD.

	RESULTADO mL/min/1,73 m2	VALOR DE REFERÊNCIA mL/min/1,73 m2
CKD-EPI 2009		
Indivíduo afrodescendente :	superior a 90	superior a 60
Indivíduo não afrodescendente:	82	superior a 60
CKD-EPI 2021 :	84	superior a 60
MDRD		
Indivíduo afrodescendente :	superior a 60	superior a 60
Indivíduo não afrodescendente:	superior a 60	superior a 60

NOTA 1: O resultado descrito se refere a uma estimativa da taxa de filtração glomerular obtida por meio de cálculo. Caso haja discordância entre o resultado e o quadro clínico do paciente, sugere-se a determinação da taxa de filtração glomerular pelo método padrão através da coleta de urina de 24 horas.

NOTA 2: A estimativa da taxa de filtração glomerular pode apresentar flutuações em função da variação biológica do nível de creatinina no sangue, inclusive decorrente do tipo de dieta ou uso de medicamentos. O cálculo não é aplicável em pacientes com creatinina sérica instável, na insuficiência renal aguda e nos portadores de massa muscular elevada ou muito baixa.

NOTA 3: Para as equações CKD-EPI 2009 e MDRD são apresentados dois resultados, levando-se em consideração as diferenças étnicas, conforme indicado em literatura médica. O valor a ser considerado é aquele que corresponde a etnia do paciente.

NOTA 4: O resultado obtido pela equação CKD-EPI 2021 é único e aplicável para todas as etnias.

Referências:
Levey AS et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2009; 150:604-612.
Levey AS et al. New creatinine and cystatin C based equations to estimate GFR without race. N Engl J Med 2021; 385:1737-1749.

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 09:05 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: DF0363846C91429908645FB689CE6EF8D862626902C9F54D7173FB43B9A3DA35

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

LDL-COLESTEROL, soro
Método: Cálculo baseado na fórmula de Martin/Hopkins

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
149 mg/dL	Maior ou igual a 20 anos:
	Com ou sem jejum de 12 horas:
	Ótimo : menor que 100 mg/dL
	Desejável : de 100 a 129 mg/dL
	Limítrofe : de 130 a 159 mg/dL
	Alto : de 160 a 189 mg/dL
	Muito alto : maior ou igual a 190 mg/dL

NOTA(1): Os valores de referência para LDL-colesterol descritos neste laudo foram estabelecidos para avaliação do perfil lipídico na prevenção primária.

NOTA(2): Conforme categoria de risco cardiovascular, poderão ser definidos valores de metas terapêuticas individualizadas.
Paciente de baixo risco : menor que 130 mg/dL
Paciente de risco intermediário: menor que 100 mg/dL
Paciente de alto risco : menor que 70 mg/dL
Paciente de muito alto risco : menor que 50 mg/dL

NOTA(3): Referências:
Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017 da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019.

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 09:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: B7F4E3D8D2552FE34BE6FF28F50E007AEAA9952F646D10EDD25CE5C7AEFEBEA7

COLESTEROL TOTAL, soro
Método: Ensaio enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
216 mg/dL	Maior ou igual a 20 anos:
	Com ou sem jejum de 12 horas:
	Desejável: menor que 190 mg/dL.

NOTA: Referências:
Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017 da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019.

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 09:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 26DF6FE397EA7DC1A1AF5BAFDEC2880F15C4511B5F94E410736C8B5D039F25DE

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

HDL-COLESTEROL, soro
Método: Ensaio homogêneo enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
42 mg/dL	Maior ou igual a 20 anos: Com ou sem jejum de 12 horas: Desejável: maior que 40 mg/dL.

NOTA: Referências:
Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017 da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019.

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 09:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 619E9B20D18571D4C50C8674473E13BBC81D30A126AFE1C92754E3AF8348F7F1

TRIGLICERIDES, soro
Método: Ensaio enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
125 mg/dL	Maior ou igual a 20 anos: Com jejum de 12 horas: Desejável: menor que 150 mg/dL Sem jejum de 12 horas: Desejável: menor que 175 mg/dL

NOTA(1): A correta interpretação deste resultado é dependente das condições de coleta da amostra, ou seja, com ou sem jejum de 12 horas. O resultado de cada parâmetro do perfil lipídico, cujo sangue foi coletado sem jejum, deve ser avaliado criteriosamente em conjunto com os dados clínicos. Na eventualidade de resultados clinicamente não consistentes, a repetição após um período de jejum de 12 horas está indicada, à critério médico, evitando-se uma alimentação rica em gorduras e carboidratos previamente a nova coleta de sangue, além da abstinência de bebidas alcoólicas por 72 horas.

NOTA(2): Referências:
Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017 da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019.

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 09:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 9002481CC687E4EE0D81E24CFCB771DB40D8649D95B5473431FCDBCC7E7A9A2F

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

VLDL-COLESTEROL, soro
Fórmula de Martin/Hopkins

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
25 mg/dL	Maior ou igual a 20 anos: Com jejum de 12 horas: Desejável: menor que 30 mg/dL Sem jejum de 12 horas: Desejável: menor que 35 mg/dL

NOTA: A correta interpretação deste resultado é dependente das condições de coleta da amostra, ou seja, com ou sem jejum de 12 horas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 09:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 15A13354A0A3AE9D39CE2BC97CF4DE7A5ED730D00E47EAE514A1363CBC649791

NÃO-HDL-COLESTEROL, soro
Método: Cálculo

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
174 mg/dL	Maior ou igual a 20 anos: Com ou sem jejum de 12 horas: Ótimo : menor que 130 mg/dL Desejável : de 130 a 159 mg/dL Alto : de 160 a 189 mg/dL Muito alto: maior ou igual a 190 mg/dL

NOTA(1): Os valores de referência para Não-HDL-colesterol descritos neste laudo foram estabelecidos para avaliação do perfil lipídico na prevenção primária.

NOTA(2): Conforme categoria de risco cardiovascular, poderão ser definidos valores de metas terapêuticas individualizadas.
Paciente de baixo risco : menor que 160 mg/dL
Paciente de risco intermediário: menor que 130 mg/dL
Paciente de alto risco : menor que 100 mg/dL
Paciente de muito alto risco : menor que 80 mg/dL

NOTA(3): Referências:
Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017 da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019.

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 09:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: F6F92F05588FA5DAF994B40938E9E800E889EBC2579BDDF5B88E14036C84A6DF

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

URINA TIPO I - JATO MEDIO

Metodologia: Leitura automatizada de tiras reagentes e análise do sedimento por citometria de fluxo, análise digital de imagens e/ou microscopia com contraste de fase.

RESULTADO		VALORES DE REFERÊNCIA
EXAME FÍSICO-QUÍMICO		
COR	: amarela	
ASPECTO	: límpido	límpido
pH	: 7,0	de 5,0 a 8,0
DENSIDADE	: 1,013	de 1,010 a 1,030
PROTEÍNAS	: inferior a 0,10 g/L	inferior a 0,10 g/L (negativa)
GLICOSE	: inferior a 0,3 g/L	inferior a 0,3 g/L (negativa)
CORPOS CETÔNICOS	: negativa	inferior a 5,0 mg/dL (negativa)
BILIRRUBINA	: negativa	inferior a 1,0 mg/dL (negativa)
UROBILINOGÊNIO	: inferior a 1,0 mg/dL	inferior a 1,0 mg/dL (negativa)
NITRITO	: negativa	negativa
PESQUISA DE ELEMENTOS FIGURADOS		
CÉLULAS EPITELIAIS	: raríssimas	
LEUCÓCITOS	: 1.000/mL	inferior a 20.000/mL
ERITRÓCITOS	: 3.000/mL	inferior a 10.000/mL
CILINDROS	: ausentes	

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 03/02/2026 22:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: F7C64BC64BF30C560819AF33050C9377454D90A089ECFBA1E105760170BD1773

ELETROCARDIOGRAMA, DE ESFORCO - CHECK-UP

TESTE ERGOMÉTRICO

Idade: 28 anos Peso: 81 kg Altura: 1,80 m
Indicação: "check-up"
Medicação: Minoxidil

RELATÓRIO

Exame realizado em condições técnicas satisfatórias. O protocolo utilizado foi de rampa, em esteira rolante e sistema de registro eletrocardiográfico em 12 derivações modificadas e simultâneas, onde CM5=I. Eletrocardiogramas clássicos obtidos pelo sistema de derivações de Mason e Likar.

Os traçados eletrocardiográficos durante e após o exercício não mostraram modificações morfológicas significativas, comparados aos iniciais.

Ausência de arritmias.

Comportamento normal da pressão arterial durante o exercício.

Ausência de sintomas sugestivos de anormalidades cardiovasculares.

A fase de esforço foi interrompida devido ao limite máximo de frequência cardíaca preconizada para a idade ter sido ultrapassado, com manifestação de intenso cansaço físico.

COMENTÁRIO:

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

Resposta cardiovascular normal ao esforço físico máximo.

Laudo elaborado de acordo com a Diretriz Brasileira de Ergometria em População Adulta, Arq. Bras. Cardiol. 2024; 121(3): e20240110.

CONTROLES

FC Máxima: 192 bpm
FC Submáxima: 167 bpm

Fase de Repouso

Posições	PA (mmHg)	FC (bpm)
Deitado	120/070	065
Sentado		
Ortostático	110/070	081

Fase de Exercício

Estágio	Tempo (min)	T.Total	m.p.h./ %	PA (mmHg)	FC (bpm)
1	00:02:00	00:02:00	3,7/00,0	120/070	099
2	00:01:00	00:03:00	4,3/00,0	120/070	110
3	00:01:00	00:04:00	5,0/00,0	130/070	126
4	00:01:00	00:05:00	5,6/00,0	140/070	139
5	00:01:00	00:06:00	6,2/00,0	140/070	153
6	00:01:00	00:07:00	6,8/00,0	150/070	169
7	00:01:00	00:08:00	7,4/00,0	160/070	176
8	00:01:00	00:09:00	8,0/00,0	-	184
9	00:01:00	00:10:00	8,0/05,0	-	190
10	00:00:53	00:10:53	8,0/10,0	-	196

Fase de Recuperação

Estágio	Tempo (min)	PA (mmHg)	FC (bpm)
1	00:01:00	180/070	173
2	00:02:00	170/070	122
3	00:04:00	150/070	104
4	00:06:00	120/070	103

Laudado e Assinado por: Dr. DANIEL CAMIS BURATTI - CRM: 121209

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

LIBERADO EM: 03/02/2026 10:07
Assinatura digital avançada: C9BCCF2EA18D33D1A3450C507331B40CE0708AA5533C0490EDE56B6166FA3535

ULTRASSONOGRAFIA, ABDOMEN SUPERIOR COM AVALIACAO RENAL - CHECK-UP

ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR COM AVALIAÇÃO RENAL

Fígado com dimensões normais, contornos regulares e margens finas. Parênquima com textura homogênea e ecogenicidade preservada.
Veias porta e hepáticas sem alterações.

Vesícula biliar de forma, contornos e espessura das paredes normais. Ausência de cálculos no seu interior.
Não há dilatação das vias biliares intra ou extra-hepáticas.

Pâncreas de dimensões, contornos e textura habituais.
Não há dilatação do ducto pancreático principal.

Baço com dimensões normais, sem alterações texturais.

Aorta e veia cava inferior com trajeto, paredes e calibre normais.

Rins tópicos, com dimensões normais (RD = 12,0 cm e RE = 11,2 cm) e contornos regulares. Parênquima com espessura e ecogenicidade normais.
Não há evidência de cálculo ou dilatação do sistema coletor.
Vários nódulos corticais hiperecogênicos circunscritos e homogêneos no terço médio à esquerda, medindo até 1,4 cm.

Ausência de líquido livre na cavidade peritoneal.

OPINIÃO:

Nódulos de provável natureza angiomiolipomatosa no rim esquerdo. O maior nódulo apresentou aumento de suas dimensões. A avaliação por ressonância magnética com o uso de meio de contraste intravenoso pode fornecer informações adicionais.

Laudado e Assinado por: Dra. CLARISSA L SOARES PEREIRA BELENTANI - CRM/SP: 144930 - RQE: 32819

LIBERADO EM: 03/02/2026 08:48
Assinatura digital avançada: EB7C683C8159A36BF39BCE0DDEC5E776162C96298AF7894FB69B884B48199BE7

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

LAUDO FINAL DO CHECK-UP
São Paulo, 9 de fevereiro de 2026

Prezado Sr. MARCOS PAULO OLIVEIRA,

Após a análise dos dados fornecidos pelo seu exame clínico e pelos exames complementares, chegamos a muitas conclusões a respeito de sua saúde.
Seguem abaixo as descrições das alterações detectadas no seu Check-up Fleury, bem como as condutas que devem ser tomadas para o encaminhamento de cada uma delas.

LDL-colesterol alterado:

O nível plasmático de LDL-colesterol é um importante fator de risco cardiovascular, e a sua redução se associa à diminuição de eventos cardiovasculares (como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral). Com base na estratificação de risco cardiovascular proposta pela atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017), sugerimos que o seu valor de LDL-C seja idealmente reduzido em cerca de 30 % (atual: 149 mg/dL). Para reduzir o LDL-colesterol, em geral é importante a adoção de medidas saudáveis de estilo de vida, mas em alguns casos, é necessário iniciar tratamento farmacológico. É importante que seja feita a melhor abordagem terapêutica para o seu caso.

Obs 1: Segundo a calculadora para estratificação de risco cardiovascular proposta pela atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017), seu risco de apresentar um evento cardiovascular (coronariano, acidente vascular cerebral, insuficiência vascular periférica ou insuficiência cardíaca) em 10 anos é considerado baixo.

Glicemia de jejum discretamente alterada:

O diabetes do tipo 2, a forma mais comum da doença, acomete pessoas na fase adulta. Seu desenvolvimento silencioso faz com que seja muito importante um diagnóstico precoce. Antes do aparecimento de qualquer sintoma, o diabetes já causa alterações nas artérias, constituindo um fator de risco para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares.
A dosagem de sua glicemia de jejum (100 mg/dL) não é compatível com o diagnóstico de diabetes neste momento. No entanto, trata-se de um valor anormal que requer acompanhamento. É importante o seguimento clínico-laboratorial diante desse quadro.

Linfocitose, eosinofilia e plaquetose ao hemograma:

É importante seja feita uma investigação complementar a critério médico.

Saturação de transferrina discretamente elevada (51 %):

Houve uma melhora em relação à última mensuração. É importante a avaliação de seu clínico para o cuidado das anormalidades metabólicas.

Nódulos no rim esquerdo compatíveis com angiomiolipomas:

Angiomiolipomas são tumores benignos dos rins, compostos por pequenos vasos, células de gordura e musculares. Geralmente são achados de exames, pequenos, e não provocam nenhum sintoma, demandando apenas seguimento. Quando crescem de forma importante, o fato de apresentarem vasos em sua composição aumenta o risco de ruptura e sangramento. O seu

CONTINUAÇÃO **(LAUDO FINAL DO CHECK-UP)**

acompanhamento deve ser feito por um urologista. No seu caso, devido ao aparente aumento de tamanho de um dos nódulos, será importante que seja feito um novo detalhamento diagnóstico junto ao urologista e definição de conduta específica.

Vacinas:

O resultado de sua sorologia para o vírus da hepatite A sugere a ausência tanto do contato viral prévio como de proteção vacinal específica. Portanto, recomendamos esquema vacinal completo para hepatite A.

Obs 2: Aguardamos os resultados de ÁCIDO ÚRICO e SOROLOGIAS dentro desse Check-up.

Atenção: Este laudo foi redigido com base nos achados clínicos e nos resultados dos exames realizados até o momento, sendo que poderá sofrer alterações na hipótese de haver exames pendentes e/ou revisão de resultados. Ressalta-se que os exames realizados posteriormente deverão ter seus resultados analisados pelo médico da empresa ou pelo médico assistente do cliente. A equipe do Check-up Fleury está à disposição para solucionar eventuais dúvidas referentes a esses exames.

EXAME FÍSICO:

Exame Físico Geral 1

- Impressão geral: Bom estado geral, corado, hidratado, eupneico, acianótico, anictérico.
- Pressão arterial sistólica (mmHg): 114
- Pressão arterial diastólica (mmHg): 70
- Frequência cardíaca: 60 bpm

- Inspeção da pele: Fototipo IV. Fotodano leve. Ausência de lesões suspeitas de malignidade. Nevo azul cotovelo D 4 mm.
- Unhas das mãos e dos pés: Normais.

Exame Físico Especial 1

Segmento cefálico:

- Palpação cervical: tireoide palpável e FE.
- Ausculta das carótidas: Ausência de sopros.

Tórax:

- Semiologia cardíaca:
 Palpação: Ictus não palpável, sem frêmitos.
 Ausculta: Bulhas rítmicas em dois tempos, sem sopros.
- Semiologia pulmonar:
 Ausculta: Murmurio vesicular presente em todos os campos pulmonares, ausência de estertores, roncos ou sibilos.

Exame Físico Geral 2

- Peso: 81,4 kg
- Altura: 1,8 m
- IMC: 25,12 kg/m2
- Circunferência abdominal: 83 cm

CONTINUAÇÃO **(LAUDO FINAL DO CHECK-UP)**

- Linfonodos:

Cadeia cervical: Ausência de linfonodos aumentados.
Cadeia supra-clavicular: Ausência de linfonodos aumentados.

- Palpação dos pulsos:

Pulsos radiais: Presentes e simétricos.
Pulsos pediosos: Presentes e simétricos.
- Extremidades: Boa perfusão periférica, ausência de cianose, edema, ou de varizes nos membros inferiores.

Exame Físico Especial 2

Segmento Cefálico:

- Cavidade oral: Ausência de lesões macroscópicas suspeitas de malignidade.

Abdômen e Pelve:

- Semiologia abdominal: Abdômen plano, flácido, indolor à palpação superficial e profunda; ausência de visceromegalias; RHA presentes e normais; ausência de sopros; lojas renais livres; hipogástrio livre.

- Anéis inguinais: Normais, ausência de hérnias.

- Órgãos genitais externos:
Pênis: Meato tópico, glande normal, sulco bálano-prepucial normal, mucosa e pele de aspecto normal, ausência de lesões dermatológicas; palpação normal.
Bolsa testicular: Ausência de alterações dermatológicas ou de hidrocele.
Cordões espermáticos: Ausência de tumorações; ductos deferentes presentes e normais; ausência de varicocele.
Testículos e epidídimos: Testículos de topografia habitual, tamanho e consistência normais; ausência de nódulos; epidídimos tópicos, ausência de cistos ou tumorações.

Inspeção do orifício anal:

- Inspeção: Orifício anal de aspecto normal; ausência de plicomas, fissuras, fístulas, lesões vegetantes ou de mamilos hemorroidários protrusos.

Toque Retal:

Não realizado, paciente com menos de 50 anos.

Aparelho Locomotor:

Ausência de dor ou crepitação à mobilização de mãos, joelhos e quadris.
Boa mobilidade dos ombros. Ausência de desvios da coluna.

O Check-up Fleury está a sua disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Dr. Carlos Alberto Avellaneda Penatti
CRM 97.358

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

CONTINUAÇÃO **(LAUDO FINAL DO CHECK-UP)**

Dr. Vinícius Broseghini Pinto
CRM 169.842 - Dermatologia

Dr. José Henrique Santiago
CRM 178.624 - Urologia

LIBERADO EM: 09/02/2026 16:39
Assinatura digital avançada: 236FFB5EA8D5320520D09578F305BE6A29A90418F82A6C19543263CD0A3E167A

HEMOGLOBINA GLICADA (A1C), sangue total
Método: Cromatografia em coluna de troca iônica em sistema de HPLC

RESULTADO

5,3 %

Esse valor de hemoglobina glicada corresponde à glicemia média estimada de 105 mg/dL.

VALORES DE REFERÊNCIA

Indivíduos sem diabetes mellitus:

Menor que 5,7% - baixo risco de desenvolvimento de diabetes
5,7 a 6,4% - risco aumentado para diabetes
Maior ou igual a 6,5% - consistente com diabetes *

Indivíduos com Diabetes mellitus:

- A meta de A1C deve ser individualizada. Em geral, recomenda-se uma A1C abaixo de 7%

Standards of Medical Care in Diabetes
Diabetes Care, 45 (Supp 1):S17-S38, 2022

* Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes mellitus requer confirmação por um segundo teste. Válido para metodologias certificadas pelo "National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP)".

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 08:32 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR PEDRO SADDI ROSA CRM 107742SP
Liberado por: ALVARO MACIEL DE OLIVEIRA CRBM 29826SP
Assinatura digital avançada: 697AFD04A660CA0FC14549623DF253702BAD9646BE44158777A91CC83288605D

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

HORMONIO TIROESTIMULANTE (TSH), soro
Método: Ensaio eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
1,5 mUI/L	20 - 59 a: 0,45 a 4,5 mUI/L

NOTA(1): O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 00:40 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 2DED6C4FAB90E7494A6A647DECEAE14C301DE8F6C3637E4956A4EFDF087BD731

BIOIMPEDANCIA, ANALISE DE COMPOSICAO CORPORAL
LAUDO ANEXADO

Laudado e Assinado por: DR. EDGAR GIL RIZZATTI - CRM: 94199

LIBERADO EM: 03/02/2026 08:49
Assinatura digital avançada: 6197004FDFF45F8F09C8478A5C0F58CDE4FC62DAA2DF1BD8A3B2262661F1397D

GLICOSE, soro
Método: Enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
100 mg/dL	70 a 99 mg/dL

RECEBIDO/COLETADO EM: 03/02/2026 - LIBERADO EM: 04/02/2026 09:06 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR PEDRO SADDI ROSA CRM 107742SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: B63C6B8A096FDD5B76B8B9B24558C043AB08FFF92800DFFEA3B2E0C22EF984AC

ACIDO URICO, soro
Método: Enzimático colorimétrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
4,4 mg/dL	Masculino: 3,4 a 7,0 mg/dL

NOTA: Em pacientes em tratamento para gota, recomenda-se níveis séricos de ácido úrico abaixo de 6 mg/dL. Referência: Adv Rheumatol 2024. 64(1):73.

RECEBIDO/COLETADO EM: 10/02/2026 - LIBERADO EM: 11/02/2026 16:04 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 74AB817970136743B5A5A488A867AB645DB461002E5A2E164E86B10BF548F9CB

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

SIFILIS, ANTICORPOS TOTAIS ESPECIFICOS ANTI-T.PALLIDUM,soro

Método: Imunoensaio quimioluminescente com micropartículas - CMIA

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
Não reagente	Não reagente : inferior a 1,00
Índice: 0,04	Indeterminado: 1,00 a 1,50
	Reagente : superior a 1,50

INTERPRETAÇÃO: Amostra NÃO reagente para anticorpos treponêmicos.

OBS.: Resultado obtido conforme estabelecido pela Portaria nº 2.012, de 19 de outubro de 2016, do Ministério da Saúde. Persistindo a suspeita de sífilis, uma amostra deverá ser coletada após 30 dias e submetida a uma nova testagem.

RECEBIDO/COLETADO EM: 10/02/2026 - LIBERADO EM: 12/02/2026 20:04 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: BA6C4C287ED59BF63ADB2A2A2EFA317F7E01F3B8CFF55D1A57FC3CCC0A7FEF81

HIV1/HIV2, ANTICORPOS E ANTÍGENO, soro

Métodos: Imunoensaio quimioluminescente de 4a geração - CMIA
HIV1 : envelope (antígeno recombinante e peptídeo sintético)
HIV2 : envelope (peptídeo sintético)
Anticorpo monoclonal contra antígeno p24

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	Não Reagente : Inferior a 1,0
Índice: 0,05	Indeterminado: De 1,0 a 7,0
	Reagente : Superior a 7,0

Interpretação: Amostra NÃO reagente para HIV.

NOTA: Resultado obtido conforme estabelecido pelo Fluxograma 3 da Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013, do Ministério da Saúde. Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Amostra recebida em: 03/02/2026

RECEBIDO/COLETADO EM: 10/02/2026 - LIBERADO EM: 11/02/2026 11:25 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 80321508A3F54F6C3E016C0F0A2C2DB6768B5C686B079CFBE53D970175852460

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

ANTICORPOS ANTI-VIRUS DA HEPATITE C (Anti-HCV), soro

Método: Imunoensaio quimioluminescente com micropartículas - CMIA

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	Não reagente : inferior a 1,00
Índice: 0,08	Indeterminado: 1,00 a 5,00
	Reagente : superior a 5,00

NOTA(1): Este resultado indica ausência de anticorpos contra o HCV. Conforme a Portaria Nº 25 do Ministério da Saúde, de 01/12/2015, em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra, para a realização de um novo teste, mediante pedido médico.

NOTA(2): Novos valores de referência a partir de 07/01/2026.

RECEBIDO/COLETADO EM: 10/02/2026 - LIBERADO EM: 12/02/2026 20:05 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 30196EED2EA0422B52B9B0BD821057926F786CC3AE2AD2432B29F3A3D6EEC33F

ULTRA-SONOGRAFIA DO PESCOCO

ULTRASSONOGRAFIA DA TIROIDE

Tiroide tópica, com forma preservada.

Diminutos cistos coloides com até 0,4 cm.

Restante do parênquima tiroidiano com textura homogênea.

Istmo filiforme.

Lobo direito: 5,4 x 1,9 x 1,2 cm (volume: 6,7cm³).

Lobo esquerdo: 5,2 x 2,0 x 1,1 cm (volume: 6,3 cm³).

Volume tiroidiano global: 13 cm³ (normal de 6 a 15 cm³).

Não há evidência de linfonodomegalia.

OPINIÃO:

Glândula tiroide sem alterações ultrassonográficas significativas.

Laudado e Assinado por: Dra. MAURA MARIA LAMBERT - CRM/SP: 88304

EXAME REALIZADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 24/02/2026 10:34
Assinatura digital avançada: 0639CA5675DAE53848D5BF7ABE337AA9FF4504410DE6C41E33DC2C9A7197274A

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

LAUDO EVOLUTIVO

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	2140027472 03/02/2026	2140022963 23/01/2025					
Eritrócitos	5,04	5,10	----	----	----	----	4,32 a 5,67 milhões/mm3
Hemoglobina	15,1	15,2	----	----	----	----	13,3 a 16,5 g/dL
Hematócrito	45,3	46,0	----	----	----	----	39,2 a 49,0 %
Hemoglobina Corpuscular Média	30,0	29,8	----	----	----	----	27,7 a 32,7 pg
VCM	89,9	90,2	----	----	----	----	81,7 a 95,3 fL
Concentração de Hemoglobina Corpuscular	33,3	33,0	----	----	----	----	32,4 a 36,0 g/dL
RDW	13,6	12,7	----	----	----	----	11,8 a 14,1 %
Leucócitos	**8.190**(1)	**8.310**(1)	----	----	----	----	3.650 a 8.120/mm3
Neutrófilos	3.850	**5.060**(1)	----	----	----	----	1.590 a 4.770/mm3
Eosinófilos	**630**(1)	160	----	----	----	----	34 a 420/mm3
Basófilos	50	40	----	----	----	----	10 a 80/mm3
Linfócitos	**3.210**(1)	2.460	----	----	----	----	1.120 a 2.950/mm3
Monócitos	450	590	----	----	----	----	260 a 730/mm3
Plaquetas	**352.000**(1)	**372.000**(1)	----	----	----	----	151.000 a 304.000/mm3
Volume plaquetário médio	**9,1**(1)	9,4	----	----	----	----	9,2 a 12,6 fL
Ferro	155	**199**(1)	----	----	----	----	65 a 175 microg/dL
Ferro - Capac Total ligação	305	297	----	----	----	----	250 a 425 microg/dL
Ferro - Grau de Saturação	**51**(1)	**67**(1)	----	----	----	----	20 a 50 %

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	2140027472 03/02/2026	2140022963 23/01/2025					
Glicose	**100**(1)	92	----	----	----	----	70 a 99 mg/dL
Hemoglobina Glicada	5,3	5,6	----	----	----	----	----
Glicemia média estimada	105	114	----	----	----	----	----
LDL-Colesterol	149	130	----	----	----	----	----
HDL-Colesterol	42	**35**(1)	----	----	----	----	maior que 40 mg/dL
Colesterol não-HDL, soro	174	145	----	----	----	----	----
VLDL-Colesterol	25	15	----	----	----	----	----
Colesterol total	**216**(1)	180	----	----	----	----	menor que 190 mg/dL
Triglicérides	125	59	----	----	----	----	----
Creatinina	1,20	1,18	----	----	----	----	0,70 a 1,30 mg/dL
Cálculo p/afrodescendente CKD-EPI	>90	>90	----	----	----	----	Superior a 60 mL/min/1,73 m2
Cálculo p/não afrodescendente CKD-EPI	82	84	----	----	----	----	Superior a 60 mL/min/1,73 m2
Cálculo CKD-EPI 2021	84	87	----	----	----	----	Superior a 60 mL/min/1,73 m2
Cálculo p/afrodescendente MDRD	>60	>60	----	----	----	----	Superior a 60 mL/min/1,73 m2

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

LAUDO EVOLUTIVO

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	2140027472 03/02/2026	2140022963 23/01/2025					
Cálculo p/não afrodescendente MDRD	>60	>60	----	----	----	----	Superior a 60 mL/min/1,73 m2

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	2140027472 03/02/2026	2140022963 23/01/2025					
Hormônio Tiroestimulante	1,5	1,4	----	----	----	----	0,45 a 4,5 mUI/L

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	2140027472 10/02/2026	2140022963 24/01/2025					
Ácido Úrico, soro	4,4	4,5	----	----	----	----	3,4 a 7,0 mg/dL

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	2140027472 03/02/2026	2140022963 24/01/2025					
AST (TGO)	25	21	----	----	----	----	Até 40 U/L
ALT (TGP)	36	40	----	----	----	----	Até 41 U/L
Anti-HCV	NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	não reagente	----	----	----	----	Não reagente: inferior a 1,0

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	2140027472 03/02/2026	2140022963 23/01/2025					
Cor, urina	amarela	amarela	----	----	----	----	----
Aspecto, urina	límpido	límpido	----	----	----	----	limpido
pH, urina	7,0	7,5	----	----	----	----	5,0 a 8,0
Densidade, urina	1,013	1,010	----	----	----	----	1,010 a 1,030
Proteínas, urina isolada	<0,10	<0,10	----	----	----	----	inferior a 0,10 g/L
Glicose, urina isolada	<0,3	<0,3	----	----	----	----	inferior a 0,3 g/L
Corpos cetônicos, urina	Negativa	Negativa	----	----	----	----	inferior a 5,0 (negativa)
Bilirrubina, urina	Negativa	Negativa	----	----	----	----	inferior a 1,0 (negativa)
Urobilinogênio, urina	<1,0	<1,0	----	----	----	----	inferior a 1,0 (negativa)
Nitrito, urina	Negativa	Negativa	----	----	----	----	negativa
Células Epiteliais, urina	raríssimas	raríssimas	----	----	----	----	----
Leucócitos quantitativo, urina	1.000	1.000	----	----	----	----	inferior a 20000
Eritrócitos quantitativo, urina	3.000	1.000	----	----	----	----	inferior a 10000
Cilindros, urina	ausentes	ausentes	----	----	----	----	----

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DRA. THAYSA MOREIRA SANTOS CRM 141679SP

Ficha: **2140027472**
Data da Ficha: **03/02/2026**

LAUDO EVOLUTIVO

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	2140027472 10/02/2026	2140022963 24/01/2025					
HIV1/HIV2	NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	----	----	----	----	não reagente

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	2140027472 10/02/2026	2140022963 24/01/2025					
Sífilis - quimioluminescente CMIA	não reagente	não reagente	----	----	----	----	Ver resultado tradicional
Sífilis - Índice quimioluminescente CMIA	0,04	0,04	----	----	----	----	----

[1] Resultado fora da faixa de referência.